

性环境影响,柱状上皮未分化储备细胞开始增生,并逐渐转化为鳞状上皮,此过程称鳞状上皮化生,化生的鳞状上皮偶可分化为成熟的角化细胞,但一般均为大小形态一致,形圆而核大的未成熟鳞状细胞。转化区成熟的化生鳞状上皮对致癌物质的刺激相对不敏感,但未成熟的化生鳞状上皮代谢活跃,在一些物质的刺激下,可发生细胞分化不良,排列紊乱、细胞核异常,有丝分裂增加,形成宫颈上皮内瘤样变。

具流行病学调查发现 CIN 与性生活紊乱、HPV 感染,免疫抑制有关,90%以上 CIN 有 HPV 感染,早期 HPV 感染时,病变的宫颈上皮变成典型的空泡细胞,在这些细胞中可见大量的 HPV DNA 和病毒壳抗原,HPV 不适应在未成熟的细胞中生长,随着 CIN 病变严重、HPV 复制减少,病毒壳抗原消失。但具有转录活性的 HPV DNA 片段可整合到宿主细胞,导致宿主细胞的恶性转化。许多 HPV 感染妇女并无临床症

状。临床上可见许多 CIN I 自然消退。当 HPV 感染持久存在时,在一些其他因素作用下,可诱发 CIN^[2]。

用阴道镜检查宫颈,可延续放大图像 6-40 倍,掌握宫颈细胞转化的机制,可让我们更理解各种阴道镜图象形成的病理基础。

宫颈位置很隐蔽,宫颈刮片是宫颈脱落细胞的细胞学检查,很容易发生漏诊,通过 2 种检查的比较,阴道镜检查对诊断女性宫颈病变有很大的临床应用价值,对发现早期 CIN,对阻断宫颈癌发展具有重要意义,可以弥补宫颈刮片的不足,减少漏诊。

参考文献

- [1] 张志胜.阴道镜图谱.人民卫生出版社,2002,43-45.
[2] 丰有吉,沈铿.妇产科.人民卫生出版社,2005,308-310.

• 临床案例 •

6例侵袭性纤维瘤诊疗体会

鲁斌 利军 孙劲松

侵袭性纤维瘤 (aggressive fibromatosis AF) 是发生于骨骼肌肉系统的纤维组织肿瘤,又称硬纤维瘤、韧带样纤维瘤病,是一种很罕见的疾病^[1],腹壁发病率最高。多见于经产妇女,可发生于任何年龄段。在病理上为良性表现,临床上却具有侵袭性生长和极易复发的特性,但不发生转移。目前,手术为该病的主要治疗手段,放疗、化疗和内分泌治疗也有一定的作用。笔者报告 6 例 (2005 年 4 月至 2008 年 3 月) AF 患者的临床资料、诊疗体会,并复习相关文献。

1 临床资料

1.1 一般资料 全组 6 例患者年龄 1~55 岁,中位年龄 33 岁,男 2 例 (33.3%),女 4 例 (66.6%)。均为单发。肿瘤长径 0.5~12.0 cm,平均 4.5 cm。肿瘤的原发部位:四肢 1 例 (16.6%)、肩部 1 例 (16.6%)、腹壁 3 例 (50%)、骺窝 1 例 (16.6%),其中原发于腹壁与腹壁以外其他部位者的比例为 1:1。侵犯邻近骨、神经或其他器官 2 例 (33.3%)。就诊原因主要为发现质硬、固定性肿物,除有 1 例因肿物浸润其它器官时伴有疼痛外,其他患者均无症状。病程为 2 周~1 年,平均 6.4 个月。所有患者均经病理证实为 AF。

1.2 治疗方法 全组均行手术治疗,其中行局部广泛切除术 (肉眼手术切缘距肿瘤边缘外 2~3 cm) 者 4 例 (66.6%),姑息性手术 2 例 (33.3%),姑息术后行辅助放疗 1 例 (16.6%) (外院放疗剂量不详),1 例 (16.6%) 于诊断后放弃治疗。

1.3 随访 随访信息来源于电话随访及门诊复查资料,本组患者随访时间自确诊之日开始,随访截止 2008 年 6 月。

2 结果

随访至 2008 年 6 月,失访 1 例,其余全部生存。有 2 例 (33.3%) 复发,其中手术切缘阴性的病例术后复发 1 例 (16.6%),复发时间 19 个月,行 2 次根治性手术。姑息手术后行辅助放疗者 1 例复发见肿瘤缓慢增长,姑息手术后放弃治疗者失访。

3 讨论

3.1 临床特征 AF 是一种很罕见的疾病,每年的新发病例为 3~4 例/100 万人口,通常发生于 20~40 岁成人 (70%),女性较男性多见,少数发生于婴儿及儿童。发病可能与外伤、手术、雌激素水平、妊娠有关。腺瘤性息肉发病部位以腹

壁发病率最高,根据发病部位分为:①表浅或筋膜纤维瘤病,包括手掌、足跖纤维瘤病、阴茎纤维瘤病及婴儿指、趾纤维瘤病。②深部纤维瘤病,包括腹壁纤维瘤病、腹壁外纤维瘤病、腹腔和肠系膜纤维瘤病和婴儿纤维瘤病。AF 起源于肌腱膜,可见于身体任何部位的骨骼肌。AF 在组织学上表现为纤维组织的良性增生,但生物学行为介于良性纤维瘤病变和纤维肉瘤之间,即具有浸润性生长和易复发的特性,但不发生转移。AF 常常浸润邻近的骨、神经、血管及重要的脏器,使手术难度增加,即使行局部广泛切除术后,仍易复发^[2]。其复发率文献报道不一,多在 24%~72% 之间,甚至达 100%,90% 的患者在 5 年内复发,平均复发时间 15~23 个月。术后复发可能与下列因素有关:患者年龄、性别、肿瘤部位、肿瘤性质 (初发或复发)、肿瘤直径、手术切除方式与程度、手术切缘、辅助放疗。通常认为:年龄>30 岁、女性、肿瘤位于四肢、复发的肿瘤、直径>5 cm、仅行姑息切除而未行扩大切除或根治性切除、切缘阳性、术后无放疗者,术后复发率高,相反,则复发率较低^[3-6]。

3.2 诊断 在临床上发现缓慢生长的质硬、固定、无痛、扁平宽大的肿物,尤其是 20~40 岁的女性的下腹壁出现类似肿物时,应考虑 AF 的可能。影像学检查有助于确定该肿瘤的范围。该病的诊断主要依靠病理,由于穿刺细胞学与冰冻手段的局限性,最后确诊往往依赖于术后病理。

3.3 治疗 AF 具有浸润性生长和易复发的特点,所以治疗方法亦与恶性肿瘤相似。目前,治疗方案首选手术,手术原则即最大限度切除肿瘤,同时最大限度地保护肿瘤周围重要器官的功能。术式分根治性切除、扩大切除、姑息切除。放疗对不能手术切除的 AF 患者有效单纯放疗能够使本病的局部控制率达到 78%。非甾体抗炎药和三苯氧胺对不适合手术、发展较缓的病变可以优先采用。化疗对 AF 有效。对发展迅速、症状严重不能手术和 (或) 放疗的患者应该考虑化疗。常用方案:①甲氨蝶呤 30 mg/m²、长春新碱 6 mg/m² 方案化疗,每 7~10 d 1 次,连用 1 年②阿霉素 20 mg/m²、氮烯咪胺 150 mg/m² 持续静脉输注方案^[4-6];③包括环磷酰胺、阿霉素、鬼臼乙苷、顺铂等药物在内的两药或三药联合方案。综合治疗:术前用阿霉素 30 mg/d 持续输注 3 d 化疗后立即放疗,每次 3 Gy 共 10 次,放化疗结束后 4~6 周手术,平均随访 71 个月,局部复发率为 15%。

3.4 本组患者的治疗体会和启发 通过对本组病例的治疗

并结合文献,得出如下结论:①手术为主的个体化综合治疗是 AF的治疗原则;②AF的确诊往往滞后于首次手术,AF呈侵袭性生长,这为提高根治率、降低复发率带来困难;③放射治疗、非甾体抗炎药和三苯氧胺对 AF有一定的治疗效果;④化疗对 AF有效,对发展迅速、症状严重不能手术和(或)放疗的患者应该考虑化疗;⑤对不能手术的 AF患者采用术前诱导化疗放疗然后手术的方法是值得采纳的治疗模式。

参考文献

[1] Porru D, Stancati S, Giliberto GL, et al. Bilateral ureteral compression by multiple abdominal desmoid tumors in Gardner syndrome: case report and literature review. *Urology* 2004, 64 (5): 1031.

[2] Kabiri EH, AlAziz S, ElMaslout A, et al. Desmoid tumors of the chest wall. *Eur J Cardiothorac Surg* 2001, 96(5): 580-583.

[3] Gronchi A, Casali PG, Mariani L, et al. Quality of surgery and outcome in extra-abdominal aggressive fibromatosis: a series of patients surgically treated at a single institution. *J Clin Oncol* 2003, 21(7): 1390-1397.

[4] Park HC, Pyo HR, Shin KH, et al. Radiation treatment for aggressive fibromatosis: findings from observed patterns of local failure. *Oncology* 2003, 64(4): 346-352.

[5] Nuytens JJ, Rust PF, Thomas CR Jr, et al. Surgery versus radiation therapy for patients with aggressive fibromatosis or desmoid tumors: A comparative review of 22 articles. *Cancer* 2000, 88 (7): 1517-1523.

[6] Ballo MT, Zagars GK, Pollack A, et al. Desmoid tumor: prognostic factors and outcome after surgery, radiation therapy, or combined surgery and radiation therapy. *J Clin Oncol* 1999, 17(1): 158-167.

小儿先天性心脏病合并肺动脉高压的麻醉处理

杨军 姚天宇

【摘要】 目的 探讨小儿先天性心脏病合并肺动脉高压修补术的麻醉处理。**方法** 20例 6岁以下的小儿经超声多普勒或心导管检查诊断为先心伴肺动脉高压,分析术中血流动力学变化。**结果** 在中低温体外循环心脏停跳下行心脏直视术,麻醉诱导及维持过程平稳。**结论** 加强麻醉管理,合理的正性肌力药,维持血流动力学的稳定,可使患儿平稳的渡过手术期。

【关键词】 小儿先心;肺动脉高压;麻醉

总结本院 2002年 12月至 2005年 12月 6岁以下小儿先天性心脏病合并肺动脉高压修补术的麻醉处理与体会,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组共 20例,8例为房间隔缺损,12例为室间隔缺损。其中男 8例,女 12例。年龄 2~6岁,体质量 9~20 kg。患儿均有反复的呼吸道感染,部分有反复的心力衰竭史。经超声多普勒或心导管检查诊断为先心伴肺动脉高压。肺动脉平均压 5.5~8.0 kPa。

1.2 方法 术前 3 d均给予低流量氧气鼻导管吸入,小剂量硝普钠 0.5~0.2 μg/(kg·min),微量泵输入。麻醉前肌内注射氯胺酮 5~6 mg/kg阿托品 0.01 mg/kg。入手术室后行动脉穿刺,中心静脉穿刺。以咪唑安定 0.1~0.2 mg/kg芬太尼 10~20 μg/kg,维库溴铵 0.1 mg/kg诱导,经口明视气管插管 6例,经鼻明视气管插管 14例。而后接 ohmeda麻醉机行 IPPV,潮气量 10~15 ml/kg呼吸频率 20~28次/min吸呼比 1:1.5~1:2。最终呼吸参数由麻醉后血气分析和病情而定。术中间断静脉推注维库溴铵 0.1 mg/kg和吸入异氟醚。体外循环(CPB)均采用膜肺,全胶体预充,中度血液稀释。在中低温(28℃~30℃)体外循环下行心内直视手术,心脏复跳后,根据血流动力学情况应用多巴胺,异丙肾上腺素等血管活性药,静滴硝普钠,酚妥拉明以降低肺动脉压。术中监测 ECG, BP, SpO₂, CVP,尿量及血气分析。均放置肺动脉测压管,左心房测压管,术毕复跳送入 ICU呼吸机支持呼吸。

2 结果

体外循环(CPB)时间为(70±15)min,升主动脉阻断时间为(40±8)min,13例自动复跳,7例除颤复跳。复跳早期使用多巴胺 3~10 μg/kg/min与多巴酚丁胺 1.5~5 μg/(kg·min),心率慢于 110次/min应用异丙肾上腺素 0.01~0.05 μg/(kg·min),停 CPB后患儿肺动脉压均较术前降

低,平衡血压,中心静脉压后缓慢静脉推注鱼精蛋白中和肝素(1:1~1:1.5)入 ICU后呼吸机维持时间(7.47±5.33)h。

3 讨论

先天性心脏病合并肺动脉高压的患儿年龄小,体重轻,血容量少,各脏器调节功能差,对于麻醉和手术耐受性差,因此在围麻醉期当中对麻醉处理要求很高。任何低氧血症,酸中毒和情绪激动,可因肺血管压力及阻力持续增高引起严重并发症^[1]。术前小流量吸氧,应用小剂量硝普钠可解除肺血管痉挛,降低肺动脉压力,改善肺循环阻力,从而提高麻醉手术期的耐受力,减少并发症。在应用硝普钠时,应适当补充血容量,提高左室充盈压,使心排血量和每搏血量获得最大程度的改善,以防麻醉诱导期发生低血压。

术中应维持心率,血流动力学稳定,避免肺血管阻力与全身血管阻力的剧烈波动而引起心内分流的改变,肺血管阻力降低会导致低血压,全身灌注不足和酸中毒;过高会使右心负荷过大,易引起急性右心衰,轻度的过度通气是选择性降低肺血管阻力的有效方法。所以可以通过调节机械通气,麻醉深度和血管活性药物来维持血流动力学的稳定。

芬太尼麻醉具有循环稳定的优点,大剂量芬太尼不仅对体循环影响小,而且可减少应激所致的肺动脉高压反应^[2]。

体外循环预充液中适度增加胶体液,适度增加胶体压,可以防止术后肺水肿和灌注肺的发生^[3]。还应加强心肌的保护,缩短转机时间,给予适量的利尿剂。

小儿先天性心脏病合并肺动脉高压的患者术前都有反复的呼吸道感染,气管黏膜水肿,使小气道官腔狭小,体液滞留造成气道阻力增高,弥散功能障碍,氧摄取受限。针对术后呼吸支持时间长的患儿,应及时清除呼吸道分泌物,调整好气管插管的深度和位置,利用血气监测,调节 PaO₂和 PaCO₂,应用 PEEP纠正低氧和高碳酸血症。

综上所述,小儿先天性心脏病合并肺动脉高压的患儿围手术期并发症的发生率和病死率较高,通过充足的麻醉前准备,加强麻醉管理,合理的正性肌力药,维持血流动力学的稳定,避免肺动脉压的波动及各项生命体征的监测,可使患儿